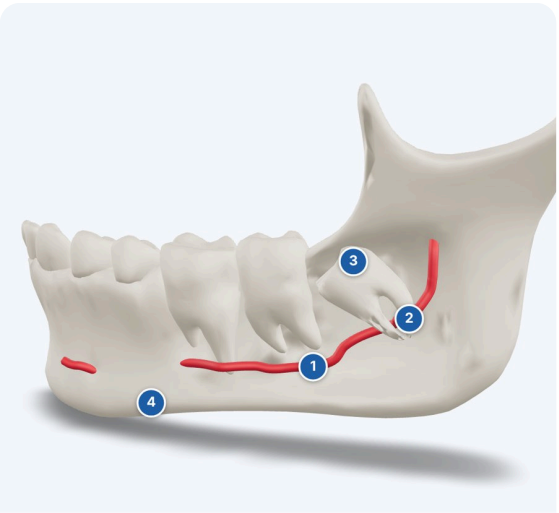
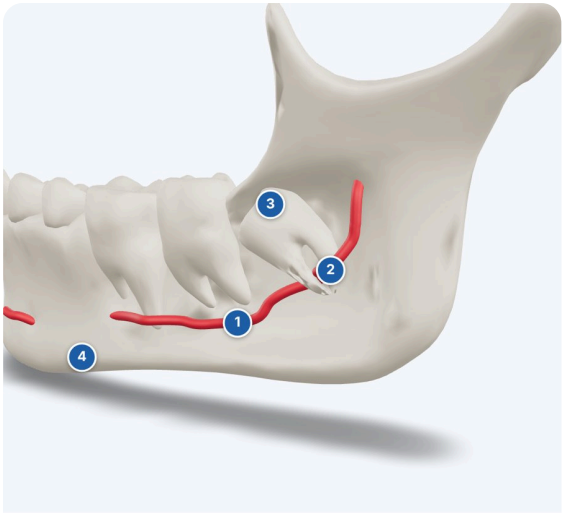
名古屋大学

うまっている下の親知らずと、そのそばを通る神経



全体



根と神経（拡大）

1. 神経・動脈　2. 親知らずの根　3. 親知らず　4. あごの骨

あごの骨と歯　神経・動脈（下あごの管の中）

どんな状態ですか？

うまっている下の親知らずは、歯ぐきと骨の下にあります。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、神経が通っています。名前は「**かしそう神経**」です。そのとなりには、動脈（血管）が通っています。この神経は、同じ側の下くちびる、あご、下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[1]

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、根を取り出すときに、神経がおされたり、のびたり、切れたりすることがあります。となりの動脈から血が出ることもあります。

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきが、しびれたり、ピリピリしたり、感じ方が変わったりします。いたむこともあります。くちびるや顔は、今までどおり動かせます。[1]

一時的な場合：感覚はもどります。多くは、数週間から数か月かかります。[1]
ずっと続く場合：感覚が完全にはもどりません。[1]

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、16の研究をまとめた報告があります。結果は次のとおりです。[2]

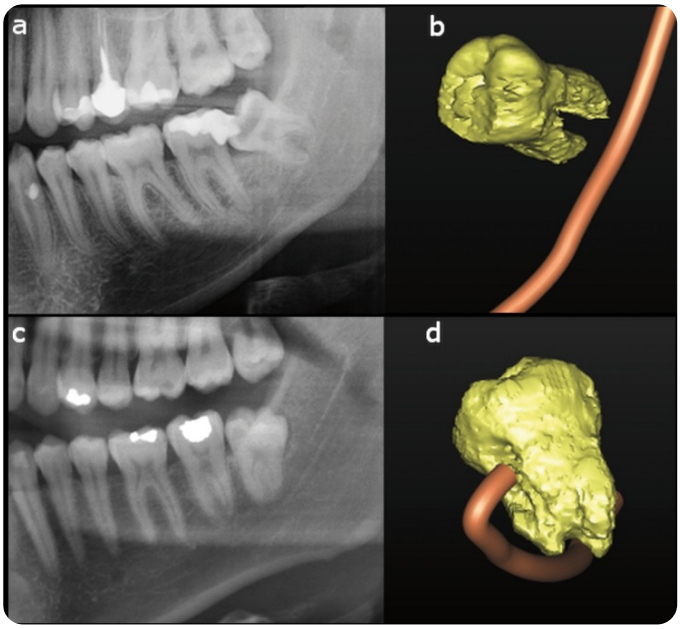
100人中 約7人
歯を全部ぬいた後に、神経が傷ついた

100人中 約1人
神経の傷が治らなかった

3Dの検査が役に立つ理由

ふつうの、口全体のレントゲン写真を「**パノラマ写真**」とよびます。これは平らな写真です。平らな写真では、本当は根が神経にふれていなくても、ふれているように見えることがあります。[3] パノラマ写真にも、根が神経に近いことを知らせるサインがあります。[4]

「**CBCT**」は、3Dのレントゲン検査です。根が本当に神経にふれているかがわかります。神経が根のどちら側にあるかもわかります。[3] 研究では、パノラマ写真よりもCBCTの方が、これをよく見分けられました。[5]



2まいのパノラマ写真（aとc）は、よく似ています。でも、CBCTで見ると、ちがいがわかります。上（b）：歯は神経にふれていません。下（d）：根が神経に巻き付いています。bとdでは、歯が黄色、神経がオレンジ色です。[3]

写真：Rodriguez y Baena R, et al. J Clin Exp Dent. 2017, Figure 1. ライセンス：CC BY 2.5。元の画像のまま使用。

CBCTは、パノラマ写真よりも多くのエックス線を使います。そのため、パノラマ写真で根が神経に近いかもしれないときに使います。[3]

担当の先生と話し合える方法

- **ぬかずに、定期的に様子を見る**（問題が起きていない場合）。
- **コロネクトミー：**歯の上の部分だけを取り、神経を囲む根は残します。同じ報告では、この方法の後に神経が傷ついたのは、約200人に1人でした。[2] ただし、残した根が動くことがあります。まれに、後で根を取り出すこともあります。
- **歯を全部ぬく。**

担当の先生に聞いてみましょう

- 歯の根は、神経にどのくらい近いですか？
- この場合、神経が傷つく可能性はどのくらいですか？
- CBCTは必要ですか？
- この場合、コロネクトミーは合っていますか？
- ぬかずにおくと、どうなりますか？

参考にした論文

1. Sarikov R, Juodzbalys G. Inferior alveolar nerve injury after mandibular third molar extraction: a literature review. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401
2. Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, Serrera-Figallo M, Torres-Lagares D. Coronectomy as an alternative technique to complete extraction of mandibular third molars with risk of nerve injury. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459
3. Rodriguez y Baena R, Beltrami R, Tagliabo A, Rizzo S, Lupi SM. Differences between panoramic and Cone Beam-CT in the surgical evaluation of lower third molars. J Clin Exp Dent. 2017;9(2):e259-e265. doi.org/10.4317/jced.53234
4. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990;28(1):20-25. doi.org/10.1016/0266-4356(90)90005-6
5. Reia VCB, de Toledo Telles-Araujo G, Peralta-Mamani M, Biancardi MR, Rubira CMF, Rubira-Bullen IRF. Diagnostic accuracy of CBCT compared to panoramic radiography in predicting IAN exposure: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021;25(8):4721-4733. doi.org/10.1007/s00784-021-03942-4

このパンフレットは、名古屋大学の研究と、多くの人に向けた情報のためのものです。一人一人の歯についての助言ではありません。一人一人の状態については、歯医者さんや、口の手術の先生が相談にのります。